

Malang, 27 Oktober 2025

Nomor : 1100/DPM/I-PB/DIR/X/2025
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth
1. PLT Direktur RS Prima Husada Malang
2. PLT Direktur RS Prima Husada Sukorejo
Di Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini Direktur PT Disa Prima Medika menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Direktur serta seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Prima Husada Group atas kerja keras dan dedikasi dalam meningkatkan mutu pelayanan serta kunjungan rumah sakit selama tahun 2025.

Dalam rangka mendukung kelancaran kinerja tahun 2026 serta penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja seluruh kegiatan tahun 2025, dimohon agar masing-masing rumah sakit di lingkungan RS Prima Husada Group mempersiapkan dan menyerahkan berkas-berkas berikut kepada PT Disa Prima Medika:

- 1. RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) seluruh program dan kegiatan Tahun 2026
- 2. TNA (Training Need Assessment) Tahun 2026
- 3. Program Kerja RS Prima Husada Tahun 2026
- 4. Laporan Kinerja RS Prima Husada Tahun 2025
- 5. Usulan Indikator Mutu dan Profil IM-Prioritas RS/Unit/Instalasi/Komite/Tim Tahun 2026

Catatan penting:

- Untuk poin (2), (3), dan (5), latar belakang atau masalah disesuaikan dengan hasil evaluasi dan kondisi tahun 2025 sesuai dengan *standar kinerja (starkes)*.
- Pengumpulan berkas poin 1–5 dilakukan oleh masing-masing Unit/Instalasi/Komite/Tim/Penanggung Jawab Program melalui Sekretariat RS, setelah mendapatkan koreksi dan persetujuan manajerial serta penapisan akhir oleh Direktur Rumah Sakit.
- Berkas tingkat Rumah Sakit (level RS) diserahkan ke PT Disa Prima Medika sesuai dengan jadwal berikut:

NO	JENIS BERKAS	TAHUN	BATAS PENGUMPULAN
1	RBA – Semua Program dan Kegiatan	2026	05 Desember 2025
2	TNA (Training Need Assessment)	2026	29 November 2025
3	Program Kerja RSPH	2026	01 Desember 2025
4	Laporan Kinerja RSPH	2025	05 Januari 2026
5	Usulan Indikator Mutu & Profil IM-Prioritas	2026	29 November 2025

Ketentuan tambahan:

- Pembuatan berkas mengikuti Tata Naskah Akreditasi Tahun 2026 (draf dari Bagian Mutu dan Pelayanan PT DPM, bulan Oktober 2025, via WAG).
- Penyusunan disesuaikan dengan level dokumen: RS / Unit / Komite / Tim.

- Penyerahan berkas dilakukan dengan upload ke alamat Google Akreditasi berikut:
 - RSPHS : <https://tinyurl.com/2025BerkasAkreRSPHS>
 - RSPHM : <https://sites.google.com/view/akreditasirsphmofficial/beranda>

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut. Atas kerja sama dan komitmen seluruh jajaran RS Prima Husada Group, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
Direktur PT. Disa Prima Medika



dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE

Lampiran : I (Satu)
Nomor : 1100/DPM/I-PB/DIR/X/2025
Tanggal : 27 Oktober 2025

FORMAT LAPORAN TAHUNAN

Catatan Penyusunan Laporan Kinerja (Laptah) Rumah Sakit:

1. Laporan Kinerja (Laptah) disusun sesuai dengan tingkatannya (level). Untuk level Rumah Sakit, laporan disusun oleh para Kepala Bidang berdasarkan rekapitulasi dan analisis dari bidang masing-masing.
2. Laptah Rumah Sakit bukan hasil salin-tempel (copy paste) dari laporan unit, instalasi, komite, atau tim. Laporan tingkat RS merupakan hasil pengolahan, penyatuan, dan pengemasan harmonis dari seluruh bidang oleh para Kepala Bidang bersama Penanggung Jawab Program, sehingga mencerminkan kinerja agregat dan integratif di level RS.
3. Setiap tabel dalam laporan wajib disertai dengan grafik, analisis, serta RTL (Rencana Tindak Lanjut).
 - o Apabila tabel terkait dengan indikator mutu, tambahkan juga siklus PDSA (Plan–Do–Study–Act).
 - o Sertakan pula rekapitulasi hasil audit mutu di level Rumah Sakit.
4. Lampiran berisi rincian data lengkap dan diletakkan paling belakang laporan.
5. Pada bagian kinerja produktivitas, setiap kolom diisi dengan kesimpulan atau rekapitulasi keseluruhan, bukan data mentah atau rincian yang sudah disajikan pada lampiran.
6. Seluruh isi laporan harus dipilah dan disusun sesuai level Rumah Sakit, bukan level unit atau instalasi, agar menggambarkan capaian kinerja secara makro

LAPORAN KINERJA TAHUNAN RSPHTAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Umum/Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM

- 2.1 Visi
- 2.2 Misi
- 2.3 Motto
- 2.4. 7 Nilai Budi Utama
- 2.5. SOTK

BAB III. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

- 3.1 SDM :
 - 3.1.1 Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi dan kebutuhan)
 - 3.1.2 Orientasi
 - 3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
 - 3.1.4. Evaluasi Kinerja Staf
- 3.2. Pengembangan Pelayanan (inovasi, kreatifitas, terobosan, layanan baru untuk meningkatkan pelayanan di unit tsb
- 3.3. Kinerja Produktifitas Unit dan Instalasi (semua program/kegiatan pelayanan di RSPH per Unit yang diambil rekapannya, garis besar, untuk rincian/detailnya masukkan lampiran)
 - 3.3.1. Penunjang terdiri dari (A.Farmasi, B.Radiologi, C.Laboratorium terpadu, D.RM, E.Gizi, F. CSSD-laundry, G.Unit kamar jenazah, H.Rehab. Medik)
 - 3.3.2 Pelayanan (IRJA : polyklinik, IGD; Irna : ICU, perina, Maternitas, R.....)
 - 3.3.3. Umum (Humas-marketing, IPS, CS, Gudang, security, penjaminan, PIPP).
 - 3.3.4. Program Nasional (PROGNAS)
- 3.4. Kinerja Produktifitas Komite MFK dan K3
 - 3.4.1. Fasilitas Kesehatam
 - 3.4.2. Gedung & bangunan
 - 3.4.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.5. Kinerja Produktifitas Komite Mutu :
 - 3.5.1 Mutu Nasional
 - 3.5.2 Mutu prioritas Rumah Sakit
 - A. Mutu Sasaran keselamatan Pasien /SKP
 - B. Mutu Pelayanan klinis prioritas
 - C. Mutu terkait Tujuan strategis rumah sakit .
 - D. Mutu terkait perbaikan sistem

- E. Mutu terkait manajemen risiko
- 3.5.3. Mutu prioritas Internal Unit (tiap unit)/Instalasi/Program
- 3.5.4 Mutu *Global Budget* (sesuai regulasi jika sudah dijalankan)
- 3.6. Kinerja Produktifitas Komite PPI
- 3.7. Kinerja Produktifitas Tim PKRS
- 3.8. Kinerja Produktifitas Tim Geriatri
- 3.9 Kinerja Produktifitas KFT
- 3.10. Kinerja Produktifitas Tim Review RM
- 3.11 Kinerja Produktifitas Komite PPRA
- 3.12. Kinerja Produktifitas Komite keperawatan
- 3.13. Kinerja Produktifitas Komite Medis
- 3.14 Kinerja Produktifitas Komite Tenaga Kes lain
- 3.15. Kinerja Produktifitas Semua TIM/komite dimasukkan semua walaupun tidak jalan/hasil 0

BAB IV.

KINERJA KEUANGAN

BAB V.

KESIMPULAN DAN SARAN

BAB VI.

PENUTUP

Pasuruan,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada

.....

Tanda Tangan dan Stempel

Lampiran : 2 (Dua)
Nomor : 1100/DPM/I-PB/DIR/X/2025
Tanggal : 27 Oktober 2025

FORMAT PROGRAM KERJA

Catatan Penyusunan Program Kerja (Proker) Rumah Sakit:

1. Program Kerja (Proker) disusun sesuai dengan tingkatannya (level), apakah pada level Rumah Sakit atau level unit/instalasi.

2. Untuk Proker level Rumah Sakit, penyusunan dilakukan oleh para Kepala Bidang (Kabid) dengan mengumpulkan dan merangkum secara garis besar program-program dari bidang masing-masing.

3. Proker RS bukan hasil salin-tempel (copy paste) dari Proker unit, instalasi, komite, atau tim. Laporan ini harus merupakan hasil pemilahan, pengolahan, dan penyusunan mandiri oleh para Kabid, sehingga menghasilkan rencana kerja terpadu dan selaras antarbidang di level RS.

PROGRAM KERJA UNIT/INSTALASI.....
RSPH..... TAHUN

BAB I.
PENDAHULUAN

- 1.1. Umum/Latar belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II
GAMBARAN UMUM

- 2.1. Visi

2.2. Misi

2.3. Motto

2.4. 7 Nilai Budi Utama

2.5. SOTK

2.6. Permasalahan kinerja tahun 2025 (ringkasan/program yang belum berhasil/ kasus-kasus yang terjadi/masalah-masalah)

BAB III.
KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
----	----------------	------------------

3.2. Sasaran

(LANDSCAPE)							
NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET

3.3. Cara Melaksanakan Kegiatan

(LANDSCAPE)							
NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET

3.4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULANTAHUN 2026												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			12/25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

3.5. Kebutuhan Anggaran

Semua anggaran akan dibiayai dari anggaran RSPH yang telah disetujui oleh PT.DPM

Contoh : Perhitungan biaya berdasarkan pemakaian rata -rata perbulan adalah sebagai berikut:

Untuk level RS bisa di kelompokkan sekup besar/rekapan per program, rinciannya di lampiran

NO	BAHAN	RATA /BL	KEBUTUHAN 1 TH		HARGA SATUAN	TOTAL Rp
1.	HANDWASH YURI/ 3,7 LITER	17	204	Jurigen	129.000	26.316.000

Contoh kebutuhan biaya pengembangan SDMRSPHTahun 2024

NO	Kegiatan /rincian kegiatan	Internal eksternal	Jumlah (satuan)	HARGA SATUAN	TOTAL Rp
1					

Dan seterusnya

BAB IV.
MONITORING DAN EVALUASI

(berisi monitoring atau pemantauan dalam bentuk observasi/supervisi/ sedangkan evaluasi dalam bentuk rapat/pertemuan evaluasi program dapat dilaksanakan sesuai pedoman rapat bulanan, triwulan dan semester atau insidental)

BAB V.
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Dicatat dalam form apa saja bukti-bukti lembar kerjanya dituliskan semuanya dan dibuat laporan (jenis laporan: bulanan, triwulan, semester dan tahunan)

BAB VI
PENUTUP

Mengetahui

Kepala Instalasi/pejabat diatasnya

Nama

Pasuruan, tanggal –bln- tahun

Kepala Ruang/Instalasi

Nama

Lampiran : 3 (Tiga)
Nomor : 1100/DPM/I-PB/DIR/X/2025
Tanggal : 27 Oktober 2025

FORMAT LAPORAN SUPERVISI DAN OBSERVASI

NO	TANGGAL	KEGIATAN	JUMLAH YANG DIPANTAU/ OBSERVASI	HASIL TEMUAN	AKAR MASALAH	RTL	PIC	KET
1								

Mengetahui
Kepala Instalasi/Pejabat di atasnya...

Nama lengkap

Lampiran : 4 (Empat)
Nomor : 1100/DPM/I-PB/DIR/X/2025
Tanggal : 27 Oktober 2025

FORMAT LAPORAN KINERJA



LAPORAN KINERJA BULANAN UNIT/PROGRAM RSPH..... BULAN.... TAHUN

I. SDM :

- 1.1 Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi, kebutuhan)
- 1.2 Orientasi (apakah ada peserta orientasi di bulan tersebut)
- 1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat yang belum dan yang sudah dilaksanakan)
- 1.4. Evaluasi Kinerja Staf

II. PENGEMBANGAN PELAYANAN

(berisi inovasi yang dikembangkan di tiap unit : missal terapi music di ruang ICU, dll, gunakan tabulasi, grafik dari hasil pencapaiannya)

III. KINERJA PRODUKTIFITAS UNIT (semua program/kegiatan pelayanan sehari-hari di unit tsb)

- 3.1.....
- 3.2..... dst

IV. Manajemen FASILITAS KESEHATAN DAN K3

- 4.1. Fasilitas Kesehatam (Alkes/Aldok/dll disesuaikan unitnya)
- 4.2. Gedung & bangunan
- 4.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Jumlah Hari cuti, Ijin, Sakit, Mangkir; Immunisasi, Kecelakaan kerja dll) isikan kesimpulan atau rekapan garis besarnya saja pada kolom sedangkan rincian lengkap di lampiran

V. MUTU : INM (jika ada), IMPRS (jika termasuk), MUTU PRIORITAS INTERNAL UNIT

VI. PPI

VII. PKRS

VIII. MONITORING DAN EVALUASI

(berisi monitoring dalam bentuk observasi/supervisi/ sedangkan evaluasi dalam bentuk rapat atau briefing, evaluasi program dapat dilaksanakan sesuai pedoman rapat: bulanan atau insidental)

No	tanggal	Kegiatan	Jumlah Yang dipantau/ observasi	Hasil temuan	Akar masalah	RTL	PIC	ket
1								

IX. PENUTUP

Mengetahui
Kepala Instalasi/Pejabat di atasnya
.....

Pasuruan, tanggal –bln- tahun
Nama Jabatan pembuat laporan

Tanda Tangan dan Stempel

Nama lengkap

Nama Lengkap

Lampiran : 5 (Lima)
Nomor : 1100/DPM/I-PB/DIR/X/2025
Tanggal : 27 Oktober 2025

KETERANGAN

1. Keterangan cara melaksanakan kegiatan BISA LEBIH DARI 1

- a. Membuat TOR
- b. Mengisi usulan di SIM
- c. Membuat Studi kelayakan
- d. Membuat telaah staf
- e. Pemberitahuan ke secretariat
- f. Disetujui Direktur
- g. Surat Tugas
- h. Disetujui PT.DPM
- i. UMANDOK, dan lain lain

2. Metode sesuai kegiatan

- a. Rapat Komite, R.Tim, R.Unit, Rapat koordinasi (rakor), Rapat kerja
- b. Audit (contoh : Audit Kepatuhan Terhadap PPI ke Ruangan atau Instalasi)
- c. Sosialisasi
- d. Surveilans
- e. Pelatihan/Diklat
- f. Simulasi
- g. Roll-Play
- h. Demonstrasi
- i. FGD
- j. Disko (diskusi kelompok)
- k. Praktek
- l. Supervisi
- m. Observasi
- n. Wawancara dan lain-lain

3. Bukti pelaksanaan Kegiatan:

- a. UMANDOK,
- b. SAK
- c. Sertifikat
- d. laporan
- e. hasil supervisi
- f. Temuan/masalah

4. Contoh :

Kegiatan PKRS ,

- rincian kegiatan : KIE kelompok
- Tujuan : meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga pasien tentang
- Metode : talkshow
- Media : IG
- Cara melaksanakan kegiatan : membuat TOR, persetujuan Direktur PT.DPM , pelaksanaan (Umandok)
- Target : 2x/minggu per unit atau perorang atau per-tim atau target 8x sebulan (pilih sesuai yg anda tentukan)
- Jadwal : tiap selasan dan kamis
- Indikator keberhasilan : edukasi kelompok terlaksana >=8x/bln + ada

- **Bukti : Umandok**

Dan seterusnya

5. Monitoring Evaluasi

Supervisi dilakukan di Tingkat Karu kebawah

NO	Aspek yang di supervisi	Standard /Target	Sesuai Standar (V)	Tidak sesuai standar (V)	Catatan temuan

Audit dilakukan di tingkat RS : dilakukan oleh / Ketua/PJ Komite/Tim/PJ program

No	Tanggal Kegiatan	Kegiatan	Jumlah Yang dipantau/ observasi	Jml-Hasil temuan		Akar masalah	RTL	PIC	ket
				SS	TS				
1									

Evaluasi : kesimpulan dilakukan dengan tampilan data rekapan bisa 1 atau 3 bulan (Audit)
untuk lihat tren dan analisis

Pencatatan dilakukan setiap hari
Pelaporan: insidentil, bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada Direktur, kepada PT.DPM

Lampiran : 6 (Enam)
Nomor : 1100/DPM/I-PB/DIR/X/2025
Tanggal : 27 Oktober 2025

FORMAT RENCANA BISNIS ANGGARAN

RBA : masing-masing program atau unit mengusulkan dan direkap di level RS

Contoh : Rencana Bisnis Anggaran Untuk Program Pkrs Di RsphTahun 2025

Rincian Kegiatan Program PKRS Tahun 2025 (Rp.....)

NO	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Tujuan	Cara Melaksanakan kegiatan	Sasaran	Target Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan	Jumlah (satuan)	Jenis	Satuan Rp	Usulan Anggaran
1	Gathering	Perusahaan	Evaluasi kunjungan	Buat Tor Pengajuan ke PT.DPM Siapkan Umandok	Perusahaan (100 Perusahaan)	1x/th	Umandok	100 org	Mamin	50.000	5.000.000
		FKTP	Menjalin kemitraan, evaluasi rujukan, pembinaan jejaring	Tor Pengajuan ke PT.DPM Siapkan Umandok	FKTP (50 org)	1x/th	Umandok	50 org	Mamin	30.000	1.500.000
2	Pembinaan komunitas	DOLINA	Pembinaan jejaring	Buat Tor Pengajuan ke PT.DPM							
		F-KUL		Buat Tor Pengajuan ke PT.DPM Siapkan Umandok							

		Senam Hamil	Meningkatkan persalinan normal di RSPH	Buat Tor Pengajuan ke PT.DPM Siapkan Umandok							
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK PROGRAM PKRS SEBESAR											6.500.000

Mengetahui
Direktur RSPH.....

diverifikasi oleh
Ketua Tim PKRS

Pelaksana Program/Sekretaris

(nama lengkap)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

Contoh : RENCANA BISNIS ANGGARAN UNTUK PROGRAM PPI DI RSPHTAHUN 2025

Rincian Kegiatan Program PPI Tahun 2025 (Rp.....)

NO	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Tujuan	Cara Melaksanakan kegiatan	Sasaran	Target Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan	Jumlah (satuan)	Jenis	Satuan Harga Rp	Total Usulan Anggaran
1	Dekontaminasi-Spilkit	Pengadaan BMHP Spilkit	Memenuhi kebutuhan pembersihan permukaan	Usulan pengadaan melalui Gudang IFRS	RS	1 Th	Tersedianya BMHP-Spilkit	12 botol	CLORHEXIDINE	70.000	84.000.000
2	Kebersihan Tangan	Pengadaan BMHP cuci tangan	Memenuhi kebutuhan BMHP cuci tangan	Usulan pengadaan melalui Gudang IFRS berdasarkan data rata-rata tahun lalu	RS	1 Th		948 Botol (500 ML)	HANDRUB	35.000	33.180.000

**Mengetahui
Direktur RSPH.....**

**diverifikasi oleh
Ketua Komite PPI**

**Pelaksana Program
IPCP**

(nama lengkap)

(nama lengkap)

(nama lengkap)



**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PT.DPM
TAHUN**

BAB I . PENDAHULUAN

- 1.1. Umum/Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum penyusunan RBA
- 1.3. Maksud dan Tujuan disusunnya RBA

BAB II GAMBARAN UMUM

- 2.1 Visi
- 2.2. Misi
- 2.3. Motto
- 2.4. 7 Nilai Budi Utama
- 2.5. SOTK

BAB III. KINERJA TAHUN BERJALAN

- 3.1 .Capaian Kinerja Pendapatan
- 3.2. Capaian kinerja Belanja Operasional
- 3.3. Laporan Arus Kas
- 3.4. Analisis Posisi bersaing
- 3.5. Kendala yang dihadapi RSPH

BAB IV. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2024

- 4.1. RBA - Target Pendapatan
- 4.2. RBA - Perkiraan pembiayaan
- 4.3. RBA Ambang Batas

BAB V. RINGKASAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

- 5.1. Ringkasan Pendapatan
- 5.2. Ringkasan Belanja
- 5.3. Ringkasan Pembiayaan

BAB VI. PENUTUP

- 6.1. kesimpulan
- 6.2. Saran

Pasuruan, tanggal –bln- tahun
Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Tanda Tangan

Nama Lengkap